

ADHD *rzadko samo*

80% dorosłych z ADHD ma jeszcze co najmniej jedno współwystępujące zaburzenie. Często ADHD jest pominięte za depresję lub lękiem.

CZAS: 10 min czytania Po diagnozie ADHD lub przy chronicznej depresji/lęku

ŹRÓDŁO: Kessler i wsp. (2006, NCS-R); Sobanski (2006); Wilens i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

Sprawdź: czy oprócz ADHD masz **inne zaburzenie**? Najczęściej: depresja, lęk, uzależnienia, zaburzenia snu, BPD. *Komorbidność jest standardem, nie wyjątkiem.* Klucz diagnostyczny: jeśli objawy nieuwagi i impulsywności **były od dzieciństwa** — to ADHD + drugie zaburzenie, nie tylko depresja. Leczą oba równolegle.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kessler i wsp. (2006, badanie NCS-R w USA, N = 9282): **80%** dorosłych z ADHD ma co najmniej jedno inne zaburzenie. Najczęściej: depresja (30–50%), lęk (30–50%), uzależnienia (25–40%), zaburzenia snu (73%), zaburzenia osobowości (10–20%, zwłaszcza z pogranicza). Wilens i wsp. (2007): ADHD jest najmocniejszym znanym czynnikiem ryzyka uzależnień. *Mechanizm wspólny:* dysregulacja dopaminergiczna. *Mechanizm samoleczenia:* substancje, ucieczki, nadkompensacja. *Mechanizm wtórny:* lata porażek → depresja, lęk, niska samoocena. **Klucz kliniczny:** nieleczone ADHD *podtrzymuje* inne zaburzenia — lek na depresję bez ADHD daje słabe rezultaty.

01

📋 Pięć najczęstszych współwystępujących zaburzeń

1 · DEPRESJA (30–50%)

„Dlaczego nic mi się nie udaje?” — bo ADHD sabotuje. Bez diagnozy myślisz, że to **Twoja wina**. Lata porażek → depresja wtórna. Leczą się oba.

2 · LĘK (30–50%)

Chroniczny stres z zapominania, spóźniania, niedotrzymanych obietnic → **uogólniony lęk**. Antycypacja kolejnej porażki. Często „leczy się” przed ADHD.

3 · UZALEŻNIENIA (25–40%)

Samoleczenie — substancje dają dopaminę, której ADHD brakuje. Najczęściej: alkohol, marihuana, nikotyna, kofeina. Czasem inne. Patrz: karta „samoleczenie”.

4 · ZABURZENIA SNU (73%)

Mózg ADHD „nie chce się wyłączyć” wieczorem. Opóźniona faza snu, gonitwa myśli. **Najczęstsza komorbidność** — i często przeoczona. Patrz: karta „higiena snu”.

5 · ZABURZENIE Z POGRANICZA (10–20%)

Nakładające się objawy: impulsywność, dysregulacja emocji. **Trudna diagnostyka**. Patrz karta „RSD vs BPD”. *Leczenie inne:* BPD wymaga DBT.

02

🔍 Reguła diagnostyczna — co było pierwsze

ADHD + DEPRESJA

Problemy z koncentracją **były od dzieciństwa** (przed depresją). Trudność z organizacją *przed* przysięgnięciem.

→ **ADHD + depresja wtórna**. Leczyć oba równolegle.

TYLKO DEPRESJA

Problemy z koncentracją **pojawiły się dopiero z depresją**. W dzieciństwie/młodości funkcjonowanie normalne.

→ **Tylko depresja**. Leczenie depresji rozwiąże objawy poznawcze.

Kluczowe pytanie diagnostyczne dla psychiatry: „czy objawy nieuwagi i impulsywności były obecne PRZED 12 r.ż.?”. Jeśli tak — to ADHD, niezależnie od współwystępującej depresji/lęku.

Zaznacz, jeśli przyznajesz się do tego. **2+ zaznaczeń w jednej grupie** = wskazana konsultacja z lekarzem.

DEPRESJA

- ☐ Chroniczny smutek/pustka od miesięcy
- ☐ Utrata przyjemności z rzeczy, które lubiłem/-am
- ☐ Zaburzenia snu (za dużo lub za mało)
- ☐ Myśli o byciu ciężarem/o śmierci
- ☐ Zmiana apetytu lub masy ciała

LĘK

- ☐ Chroniczny niepokój/martwienie się
- ☐ Napady paniki
- ☐ Fizyczne objawy lęku (bicie serca, drżenie)
- ☐ Unikanie sytuacji społecznych z lęku
- ☐ Lęk antycypacyjny przed zadaniami

UZALEŻNIENIA / SAMOLECZENIE

- ☐ Codzienne używanie substancji
- ☐ Trudność z ograniczeniem mimo prób
- ☐ Ukrywanie ilości przed bliskimi
- ☐ Używanie rano, by funkcjonować
- ☐ Bliscy wyrażali niepokój

ZABURZENIA SNU

- ☐ Zasypianie > 60 min
- ☐ Częste wybudzenia w nocy
- ☐ Budzenie rano zmęczony/-a
- ☐ Senność w ciągu dnia mimo „snu”
- ☐ Chrapanie + ranne bóle głowy

Klucz: ADHD często jest *diagnozowane jako depresja lub lęk* — bo te objawy są bardziej widoczne i lepiej znane klinicystom. Jeśli **leki na depresję nie pomagają**, a problemy z organizacją masz *od dzieciństwa* — **rozważ diagnostykę ADHD**. Kessler i wsp. (2006): mediana wieku diagnozy ADHD u dorosłych w USA wynosi 32 lata — *średnio 5-10 lat po diagnozie pierwszej komorbidności*. Nie czekaj. Pełna diagnoza to lepsze leczenie.